

INDICADO POR: Dr.º Luciano
() ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

Lucilia Eugênio Aelino
IDADE: 38 PESO: 108 ALTURA: 160 PROFISSÃO: Contadora
SINTOMAS: Dor de cabeça, cansaço, sonolência, falta de ar, engasgo
QUEIXAS: Sente falta de ar / Dor de garganta / Boca seca.
MEDICAMENTOS: Ritalina (autismo / TDAH).

PROXIMIDADE)
MÉDICO: Dr.º Luciano Rofella
MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz (15' caminhada)
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: café ALMOÇO: 12:30 LANCHE: sim JANTAR: sim.
HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 05:30 (intervalo com) (pico)

COCHILO () S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE
TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S () N
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: oral BANHEIRO/NOITE: 5X.

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 80 CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: sim MALLAMPATI: III IAH: 89 e/h SPO2: 75%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Cúrculo via endox. p/ retiras Q. do sono: 2
pedra da vesícula (linícu o venzo) Cansaço: 2

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA Boca seca: 1

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Despert. Not.: 1

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA Banheiro: 1

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 CI/CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

22/02 Avaliação Tem fobias
25 P = 7 cm H₂O - mais wisp tecido (w) lua.

27/02 P = 6 cm H₂O Relata que ainda acorda
25 IAH = 0,4 e/h e/ taquicardia, e
mauro: 6h 58' ainda despertando a
fuga: 18 l/min noite

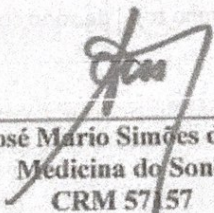
14/03/25 P = 6,0 cm H₂O demora pegar no sono
IAH: 0,4 e/h sugio leitura/oracp/ chá...
mauro: 8h 22 min.
fuga: 8 l/min silva

16/05 P = 6,0 ainda dormindo q
25 IAH = 1,3 e/h dif. p/ iniciar o sono
m. de uso: 7h
fuga: 9Q { Q. do sono: 9 / Desp. Not.: 9 / lua
Cansaço: 7 / Banheiro: 10
Boca seca: 6

CONCLUSÃO

1. Saturação da oxi-hemoglobina preservada;
2. Latência para o início do sono normal (13,5 min) (VN= até 30 min);
3. Latência para o início do sono REM diminuída (22,5 min) (VN= 70 a 120 min);
4. Eficiência do sono diminuída (84,0 %) (VN= $\geq 85\%$);
5. Índice de despertares normal 1,7 n^o/h (VN= até 15 n^o/h);
6. Percentual do estágio N1 normal (2,3 %) (VN= 2% a 5%);
7. Diminuição do percentual do estágio N2 (33,6 %) (VN= 45% a 55%);
8. Aumento do percentual do estágio N3 ondas delta (30,7 %) (VN= 13% a 23%);
9. Aumento do percentual do estágio REM (33,3 %) (VN= 20% a 25%);
10. Ronco intermitente verificado via sensor de ronco durante a leitura do exame;

Exame polissonográfico Split-Night, na segunda parte da noite para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6,0 cmH₂O.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

PROCEDIMENTO:

Exame polissonográfico noturno registrado no sistema (NeuroVirtual)®. Foram utilizados os registros de EEG: F4-M1, C4-M1, O2-M1, F3-M2, C3-M2 e O1-M2; EOG: bilateral; EMG: submentoniano; EMG: tibial bilateral; ECG: montagem D2 modificada; fluxo aéreo nasal por cânula de pressão e oronasal por termistor; esforço respiratório torácico e abdominal por pletismografia; saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) por oximetria de pulso; sensor de ronco (pela cânula nasal) e posição corporal no leito.

Parâmetros de registro recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (versão 3.0/2022)

Nome: LUCILIA EUGENIO ALBINO

Data do Exame: 21-01-2025

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA TIPO "SPLIT NIGHT"

Nome: LUCILIA EUGENIO ALBINO

Data do Exame: 21-01-2025

Peso: 108 kg

Médico Solicitante: DR. LUCIANO AUGUSTO ROTELLA
BRAGA

Sexo: Feminino

Idade: 38 anos

Altura: 1,60 m

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 21/01/2025 21:05 e finalizado às 22/01/2025 05:47.

A latência para início do sono foi de 13,5 min e a latência para o sono REM de 22,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 171,0 min, com eficiência do sono de 84,0 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 2,3 % de estágio N1, 33,6 % de estágio N2, 30,7 % de estágio N3 e 33,3 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 19,0 min. Ocorreram 15 despertares, sendo o índice de 1,7 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 22, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 22 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 7,7 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 8,4 e o IDR durante o sono NREM foi de 7,4. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 7,7 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 7,7 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 94%, a média de 95% e a mínima de 92%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 2,5 (nº/h), sendo que em REM foi de 8,4 (nº/h) e em NREM foi de 7,4 (nº/h). Permaneceu 0,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.